

# ABCÈS DU FOIE

**Durée :** Environ 45 minutes

**Niveau :** Étudiants en médecine (externat), internes, médecins généralistes

**Mots-clés :** Abscès hépatique, Abscès pyogène, Abscès amibien, Fièvre, Douleur de l'hypochondre droit, Drainage, Antibiothérapie, *Klebsiella pneumoniae*, *Entamoeba histolytica*

## Objectifs Pédagogiques

- Définir l'abcès du foie et distinguer les deux principaux types : pyogène et amibien.
- Identifier les principaux facteurs de risque et les voies de contamination.
- Reconnaître le tableau clinique typique et les signes d'alerte.
- Prescrire et interpréter les examens complémentaires pertinents (biologiques et imagerie).
- Établir les diagnostics différentiels principaux.
- Planifier la prise en charge thérapeutique d'un abcès pyogène (antibiothérapie, drainage) et d'un abcès amibien.
- Connaître les principes de prévention.

## Introduction et Contexte Scientifique

L'abcès du foie est une collection de pus localisée dans le parenchyme hépatique. C'est une pathologie infectieuse grave qui peut être mortelle en l'absence de traitement.

On distingue deux étiologies principales : l'abcès à pyogènes (bactérien), le plus fréquent dans les pays développés, et l'abcès amibien (parasitaire), prédominant dans les zones d'endémie.

Le diagnostic repose sur un trépied : clinique (fièvre, douleur de l'hypochondre droit), biologie (syndrome inflammatoire) et surtout l'imagerie (échographie et TDM abdominale).

La prise en charge est une urgence médico-chirurgicale. Pour l'abcès pyogène, elle associe une antibiothérapie prolongée et, le plus souvent, un drainage (percutané ou chirurgical). Pour l'abcès amibien, le traitement est avant tout médical par le métronidazole.

La recherche et le traitement de la cause sous-jacente (biliaire, digestive...) sont indispensables pour éviter les récurrences.

## Contexte et épidémiologie

L'abcès du foie est défini comme une collection purulente localisée au sein du parenchyme hépatique. C'est une infection potentiellement létale, avec une mortalité de 5 à 15% même avec un traitement moderne. On distingue deux grands types :

### 1. Abscès à pyogènes (bactérien) :

- \* Le plus fréquent dans les pays industrialisés (80-90% des cas).
- \* Incidence : environ 2-3 cas pour 100 000 habitants par an, en augmentation en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation des pathologies biliaires et des patients immunodéprimés.
- \* **Facteurs de risque** : diabète, pathologie bilio-pancréatique (lithiase, cancer), infection intra-abdominale (diverticulite, appendicite), immunosuppression, chirurgie hépato-biliaire récente.
- \* Les germes les plus fréquents sont les entérobactéries (\**Escherichia coli*\*, \**Klebsiella pneumoniae*\* - de plus en plus fréquent et virulent), les streptocoques et les anaérobies.

## 2. **Abcès amibien (parasitaire) :**

- \* Causé par le parasite \**Entamoeba histolytica*\*.
- \* Il s'agit de la manifestation extra-intestinale la plus fréquente de l'amibiase.
- \* Endémique dans les régions tropicales et subtropicales (Asie du Sud-Est, Amérique Latine, Afrique) où les conditions d'hygiène sont précaires.
- \* En France, il s'agit quasi-exclusivement d'une pathologie d'importation, à rechercher systématiquement chez un patient ayant séjourné en zone d'endémie.

## Physiopathologie

La contamination du foie peut se faire par plusieurs voies :

### \* **Pour l'abcès à pyogènes :**

1. **Voie biliaire (la plus fréquente, ~40%)** : Infection ascendante depuis les voies biliaires. Le plus souvent due à une obstruction (lithiase, sténose, tumeur) entraînant une angiocholite qui se complique d'abcès.
2. **Voie portale (~20%)** : Embolies septiques provenant d'une infection du territoire digestif drainé par la veine porte. Causes typiques : diverticulite sigmoïdienne, appendicite, maladie de Crohn. La thrombose septique de la veine porte est appelée pyéléphlébite.
3. **Voie artérielle (~15%)** : Dissémination hématogène lors d'une bactériémie systémique (endocardite, infection cutanée, urinaire...). Souvent responsable d'abcès multiples et de petite taille.
4. **Par contiguïté (~5%)** : Propagation d'une infection d'un organe de voisinage (ex: cholécystite aiguë gangréneuse, ulcère gastrique perforé).
5. **Post-traumatique ou iatrogène** : Surinfection d'un hématome post-traumatique ou complication d'un geste (biopsie hépatique, radiofréquence).
6. **Cryptogénique (~20%)** : Aucune porte d'entrée n'est retrouvée malgré un bilan exhaustif.

### \* **Pour l'abcès amibien :**

1. Ingestion de kystes d'\**Entamoeba histolytica*\* via de l'eau ou des aliments souillés.
2. Transformation en trophozoïtes dans le côlon, qui envahissent la muqueuse intestinale (pouvant causer une colite dysentérique).
3. Migration des trophozoïtes par la veine porte jusqu'au foie.
4. Dans le foie, les parasites provoquent une nécrose lytique du parenchyme, formant une cavité remplie d'un pus classiquement décrit comme 'chocolat' ou 'pâte d'anchois' (hépatocytes nécrosés), qui est généralement stérile à la culture bactérienne.

## Tableau clinique

Le tableau clinique est souvent non spécifique, ce qui peut retarder le diagnostic.

### \* **Signes généraux (très fréquents) :**

- \* **Fièvre élevée (>38.5°C)**, souvent de type hectique (avec de grands pics et frissons), présente dans plus de 90% des cas.

- \* Altération profonde de l'état général : asthénie, anorexie, amaigrissement.
- \* **Signes fonctionnels digestifs :**
- \* **Douleur de l'hypochondre droit (HCD) :** Le signe le plus évocateur. Elle peut être constante, sourde, et augmentée à l'ébranlement ou à l'inspiration profonde.
- \* Nausées, vomissements.
- \* **Examen physique :**
- \* **Hépatomégalie douloureuse** à la palpation.
- \* **Ictère :** Inconstant (20-30% des cas), il signe souvent une origine biliaire ou une compression des voies biliaires par l'abcès.
- \* La **triade classique (fièvre, douleur de l'HCD, ictère)**, similaire à la triade de Charcot de l'angiocholite, est en réalité peu fréquente.
- \* **Signes extra-digestifs :**
- \* Signes de réaction pleurale droite : toux, douleur basithoracique droite, épanchement pleural réactionnel.
- \* **Particularités de l'abcès amibien :**
- \* Le début est souvent plus insidieux, subaigu.
- \* L'interrogatoire est FONDAMENTAL : rechercher un séjour récent ou ancien en zone d'endémie.
- \* Des antécédents de dysenterie (diarrhée glairo-sanglante) ne sont présents que dans une minorité de cas.

## Examens complémentaires

---

### 1. Biologie :

- \* **Syndrome inflammatoire majeur et quasi-constant :**
- \* Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.
- \* CRP très élevée (souvent > 100-200 mg/L).
- \* **Bilan hépatique perturbé de manière variable :**
- \* Cholestase (élévation des Gamma-GT et des phosphatases alcalines) est le trouble le plus fréquent.
- \* Cytolyse (élévation des ASAT/ALAT) modérée.
- \* Hyperbilirubinémie si ictère.
- \* **Hémocultures :**
- \* Systématiques, à répéter lors des pics fébriles.
- \* Positives dans environ 50% des abcès pyogènes, permettant d'identifier le germe et d'adapter l'antibiothérapie.
- \* **Sérologie amibienne (Elisa) :**
- \* Indispensable en cas de suspicion d'abcès amibien (contexte de voyage).
- \* Très sensible et spécifique (>95%) en cas d'atteinte hépatique. Sa négativité élimine quasi-certainement le diagnostic.

### 2. Imagerie (clé du diagnostic) :

- \* **Échographie abdominale :**
- \* Examen de première intention, rapide et non irradiant.
- \* Montre une lésion le plus souvent unique, arrondie, hypoéchogène, mal limitée, avec un renforcement postérieur. Peut contenir des échos internes (débris).
- \* Permet de guider une ponction ou un drainage.
- \* **Tomodensitométrie (TDM) abdominale avec injection de produit de contraste :**
- \* L'examen de référence, plus sensible et plus précis que l'échographie.
- \* Montre une lésion hypodense, qui ne se rehausse pas après injection, entourée d'une coque qui se rehausse

de façon intense et précoce au temps artériel ('signe de la cocarde' ou 'rim enhancement').

\* Permet de mieux évaluer le nombre, la taille, la localisation des abcès, de rechercher des complications (thrombose portale, rupture) et surtout de rechercher une cause intra-abdominale (diverticulite, cholécystite...).

## Diagnostic différentiel

---

Devant une masse hépatique fébrile, il faut éliminer :

- \* **Tumeur hépatique nécrosée ou surinfectée :**
- \* Carcinome hépatocellulaire (CHC) sur foie de cirrhose.
- \* Métastase hépatique (notamment d'origine colorectale).
- \* L'imagerie peut être piègeuse, la biopsie est parfois nécessaire.
- \* **Kyste biliaire ou hydatique surinfecté.**
- \* **Hématome hépatique surinfecté (contexte de traumatisme).**
- \* **Pathologies de voisinage :**
- \* Cholécystite aiguë, angiocholite.
- \* Abcès sous-phrénique.
- \* Pneumopathie de la base droite.

## Prise en charge

---

L'hospitalisation est systématique. La prise en charge diffère radicalement entre l'abcès pyogène et amibien.

### A. ABCÈS À PYOGÈNES : Trépied thérapeutique

#### 1. Antibiothérapie :

- \* À débiter en urgence après les hémocultures.
- \* **Probabiliste au départ :** large spectre, active sur les BGN, les cocci Gram+ et les anaérobies. Association type C3G (Ceftriaxone 2g/j) + Métronidazole (1.5g/j). Alternative : Pipéracilline-Tazobactam.
- \* **Adaptée secondairement** aux résultats des hémocultures ou de la ponction de l'abcès.
- \* **Durée prolongée :** 4 à 6 semaines au total. Relais par voie orale possible en fonction de l'évolution clinique et biologique.

#### 2. Drainage de la collection :

- \* Indispensable dans la majorité des cas, surtout si l'abcès est volumineux (> 5 cm).
- \* **Drainage percutané radioguidé (écho ou TDM) :** C'est la technique de référence. Consiste à mettre en place un drain dans la cavité pour évacuer le pus. Moins invasif.
- \* **Drainage chirurgical (coelioscopie ou laparotomie) :** En cas d'échec du drainage percutané, d'abcès multiples et complexes, de rupture d'abcès, ou s'il faut traiter la cause dans le même temps (ex: cholécystectomie).

#### 3. Traitement de la cause :

- \* Fondamental pour éviter la récurrence.
- \* Drainage des voies biliaires, traitement d'une diverticulite, appendicectomie, etc.

### B. ABCÈS AMIBIEN : Traitement médical en première intention

- \* **Le traitement est quasi-exclusivement médical.** Le drainage est exceptionnel.
- \* **Amoebicide tissulaire :** Métronidazole (FLAGYL®) à forte dose (1.5g à 2g/jour) pendant 7 à 10 jours. L'apyrexie est généralement obtenue en 48-72h.
- \* **Puis amoebicide de contact :** Après le traitement tissulaire, pour éradiquer les kystes restants dans la lumière

intestinale et éviter les récurrences et la dissémination. Ex: Tiliquinol-Tilbroquinol (INTETRIX®) pendant 10 jours.

\* **Indications rares du drainage :**

- \* Risque de rupture imminent (gros abcès du lobe gauche, proche du péricarde).
- \* Absence d'amélioration clinique après 72h de traitement médical bien conduit.
- \* Doute diagnostique persistant avec un abcès pyogène.

## Prévention et éducation du patient

\* **Prévention de l'abcès pyogène :**

- \* Bon équilibre du diabète.
- \* Prise en charge précoce et adéquate des infections intra-abdominales (cholécystites, angiocholites, diverticulites) pour éviter leur complication.

\* **Prévention de l'abcès amibien (conseils aux voyageurs) :**

- \* Respect des règles d'hygiène alimentaire dans les pays d'endémie : 'Boil it, cook it, peel it, or forget it' (Faire bouillir, cuire, peler, ou oublier).
- \* Ne boire que de l'eau en bouteille capsulée ou de l'eau rendue potable (filtration, désinfection).
- \* Éviter les crudités, les glaçons, les jus de fruits frais préparés de façon artisanale.
- \* Lavage fréquent des mains.

\* **Éducation du patient traité :**

- \* Importance de l'observance et de la durée totale du traitement antibiotique.
- \* Informer sur les signes de récurrence qui doivent amener à consulter (fièvre, douleur).
- \* Suivi par imagerie pour s'assurer de la régression complète de la collection.

## Résumé final

L'abcès du foie est une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut systématiquement y penser devant un tableau de fièvre et de douleur de l'hypochondre droit.

L'interrogatoire est crucial pour orienter vers une origine pyogène (contexte local) ou amibienne (voyage en zone d'endémie).

Le diagnostic est confirmé par l'imagerie, le scanner abdominal injecté étant l'examen de choix.

La prise en charge est radicalement différente : l'abcès pyogène requiert une association d'antibiotiques et de drainage, tandis que l'abcès amibien répond spectaculairement au traitement médical par métronidazole seul.

Le pronostic est bon si le traitement est précoce et adapté, mais la mortalité reste significative en cas de retard diagnostique ou de complications.

### Références Bibliographiques

1. Collège des Enseignants de Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT). E. PILLY. 2023. Alinéa Plus.
2. Traité d'Hépatologie. Benhamou, Bircher, McIntyre, Rizzetto, Rodes. Flammarion Médecine-Sciences.
3. Recommandations de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) sur les infections intra-abdominales.